

"De grootste verbetering van het afgelopen jaar is de positieve studie met immuuntherapie als onderhoudsbehandeling na chemotherapie bij uitgezaaide blaaskanker", zegt prof.dr. Ronald de Wit, internist-oncoloog bij Erasmus MC Kanker Instituut. *Door Jolanda Thelosen.*

Wat zijn de ontwikkelingen bij behandeling blaaskanker?

Bij blaaskanker ontstaat de tumor meestal in het slijmvlies dat de binnenkant van de blaas bekleedt. Dat is het urotheel. Deze vorm van blaaskanker wordt daarom ook urotheelcelcarcinoom genoemd.

Blaaskanker is onder te verdelen in: oppervlakkige blaaskanker en spierinvasieve blaaskanker. Oppervlakkige blaaskanker komt het meeste voor en noemen we ook niet-spierinvasieve blaaskanker. Daarbij zit de tumor alleen in het slijmvliesweefsel. Bij spierinvasieve blaaskanker is de tumor doorgroeid in de spierlaag van de blaaswand.

De behandeling en het verloop van oppervlakkige en spierinvasieve blaastumoren zijn verschillend. De behandeling hangt af van de uitbreiding van de tumor en van het vermogen van de tumor om snel uit te breiden of te recidiveren (terugkeren).

Behandeling niet-spieerinvasieve blaaskanker

De meeste oppervlakkige blaastumoren worden verwijderd met een transurethrale resectie (TUR). De uroloog brengt operatie-instrumenten via de plasbuis in de blaasholte en schraapt het tumorweefsel weg.



Prof. dr.
Ronald de Wit

Oppervlakkige blaastumoren zullen niet snel in de diepte groeien en ook niet uitzaaien. Wel hebben ze een terugkerend karakter, waardoor na de operatie een nieuwe tumor elders in de blaas kan ontwikkelen. Om de kans op terugkeer te verkleinen volgt na de operatie meestal een behandeling met blaasspoelingen.